Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível do Foro Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 14º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110-230 - Fone: (51) 321-06500 - Balcão virtual: (51) 98010.4411 - Email: frpoareg4d2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001419-12.2023.8.21.1001/RS

AUTOR: CRISTINA FANTINEL ARAUJO

AUTOR: ERIKA ARAUJO TREMPER

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

SENTENÇA

Vistos.

ERIKA ARAUJO TREMPER, representada por sua genitora **CRISTINA FANTINEL ARAUJO**, devidamente qualificada nos autos, ajuizou **AÇÃO ORDINÁRIA** em face de **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que a parte autora, Erika, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 e CID 11 6A02). Aduziu, ainda, que devido à sua condição e visando possibilitar a continuidade dos seus estudos, necessitaria ser assistida, necessitando, assim, de acompanhante terapêutico especializado para ajudar e acompanha-la nas atividades em sala de aula, bem como identificar maiores dificuldades no aprendizado. Alega que sua escola não possui o referido profissional, mas que não se opõe à presença de um profissional, desde que não onere a instituição de ensino. Nesse sentido, fez a solicitação ao plano de saúde, ora Réu, para custear os valores, no entanto, a requerida indeferiu o pleito da parte requerente. Teceu considerações acerca da incidência do CDC ao feito em comento e da abusividade da negativa da cobertura postulada, requerendo, liminarmente, o fornecimento do aludido tratamento e, ao final, que a requerida fosse compelida a fornecer o postulado acompanhamento/tratamento médico. Requereu a AJG e juntou documentos (evento 1).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido liminar (evento 06).

Deferida a AJG, restou indeferida a liminar pleiteada (evento 08).

A parte autora emendou a inicial (evento 13).

Citada (evento 7), a requerida apresentou contestação impugnando o valor da causa. No mérito, alegou, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura. Destacou que o tratamento reclamado não estaria no rol da ANS e que não estaria obrigado a arcar com o tratamento requerido fora da sua rede. Impugnou as horas solicitadas a título de acompanhante terapêutico (30 horas), salientando que tal seria obrigação da própria escola e não do plano de saúde. Requereu, ao final, a improcedência dos pleitos autorais e juntou documentos (evento 11).

Houve réplica (evento 13).

Rejeitada a impugnação ao valor da causa, prolatado despacho saneador e instadas as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas (evento 48), a parte autora juntou documento (evento 55), não tendo a ré se manifestado (evento 60).

O Ministério Público opinou pela procedência dos pleitos autorais (evento 63).

Vieram-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de **AÇÃO ORDINÁRIA** ajuizada por **ERIKA ARAUJO TREMPER**, representada por sua genitora **CRISTINA FANTINEL ARAUJO**, devidamente qualificada nos autos, em face de **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**, em que entendo cabível o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que, além da desnecessidade de produção de prova em audiência, as partes, embora devidamente intimadas para tanto, não postularam a produção de outras provas.

Inexistem preliminares pendentes de análise, razão pela qual passo, diretamente, ao julgamento do mérito da ação.

No caso em comento, a parte requerente possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 e CID 11 6A02), postulando, em síntese, que a requerida providencie o custeio de acompanhante terapêutico especializado, visando auxiliar e acompanhar menores com TEA – Transtorno do Espectro Autista - e custeio do tratamento com hidroterapia.

Todavia, alterando meu entendimento e inobstante os argumentos expendidos pela parte autora, entendo, com base no entendimento sedimentado quando do julgamento dos EREsp 1886929 e REsp 1889704, o que, por si só, impede o reconhecimento de qualquer ilicitude na negativa de cobertura pela ausência de previsão no rol da ANS.

No ponto, entende-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo, de forma que as operadoras do plano de saúde só estariam obrigadas a cobrir outros tratamentos, não previstos no aludido rol, em situações excepcionais, observando-se as seguintes teses firmadas pela Superior Instância:

> *1) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;*
>
> *2) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;*
>
> *3) É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*
>
> *4) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*

De igual modo, a Lei nº 14.454/22, que inclui novos parágrafos no art. 10 da Lei 9656/98, estabeleceu os critérios para a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não inclusos no rol da ANS, *in verbis*:

> *Art. 10. (...)*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Verifica-se a partir do aludido julgamento do STJ, que a cobertura por eventuais tratamentos fora do rol da ANS exigirão, concomitantemente, além da indicação do médico assistente, a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como, por exemplo, Conitec e Natjus) e estrangeiros.

Assim, em relação à postulada hidroterapia, impõe-se a observância do Parecer Técnico nº 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, que exclui o dever de cobertura, pelas operadoras dos planos de saúde, das terapias denominadas Pilates, Reeducação Postural Global (RPG), Hidroterapia, Equoterapia, Musicoterapia, Arteterapia, Massoterapia, Terapia de Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reflexoterapia, *in verbis:*

PARECER TÉCNICO Nº 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021

COBERTURA: PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA e REFLEXOTERAPIA

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.º 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA e REFLEXOTERAPIA não se encontram listados no Anexo I, da RN n.º 465/2021, e, portanto, não possuem cobertura em caráter obrigatório.

No ponto, corroborando meu entendimento, colaciono as jurisprudências:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) , postula a cobertura dos tratamentos multidisciplinares com fonoaudiologia (2x por semana), terapia ocupacional (2x por semana), psicoterapia paciente/familiar (1x por semana), tudo especializado em TEA, com utilização e/ou supervisão das diretrizes e métodos ABA, Integração sensorial e neuro-evolutivo "Bobath", musicoterapia especializada em autismo (1x por semana), equoterapia especializada em autismo (1x por semana), com*

sessões de no mínimo 50 minutos de duração, bem como terapias, medicamentos, equipamentos/órteses e exames específico , julgada parcialmente procedente, na origem. Ao atender o comando do art.197 da Carta Constitucional, a Lei n. 9656/98, disciplinou os planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde (SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), via Lei n.9961/00, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Imprescindível considerar que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.10 da Lei n.9656/98, que garante o mínimo assistencial de caráter negocial privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado em litígio.O Plano de Referência estabelece exceções (art.10, incs.I a X, Lei n.9656/98), ou seja, hipóteses de não-cobertura, ressalvando-se a contratação facultativa complementar (art.12) e admissão por regulação da ANS (art.10,§1º), que poderá inclusive abranger transplantes e procedimentos de alta complexidade (art.10,§4º). Como consectário, não há como fugir do caráter limitador e taxativo do rol atualizado da ANS, agência reguladora, sob pena de colocar em risco a saúde financeira e existencial dos próprios Planos Privados de Saúde.É incontroverso nos autos que o menor é portador DE transtorno do espectro autista (TEA- CID F 84), acostando ao feito laudos médicos evento 3, PROCJUDIC2 que lhe apontam tratamentos específicos, cuja cobertura restou negada pela requerida. Como é sabido, diante da complexidade do caso, não existe uma única abordagem no tratamento do autismo, mas várias delas, todas conectadas, sendo o profissional médico apto a tratar a CID do paciente, a pessoa indicada para identificar o tipo do tratamento que deve ser realizado. Assim, considerando que, no Rol da ANS existe a previsão de cobertura para o tratamento multidisciplinar com psicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, tenho que o método indicado pelo médico assistente deve ser coberto, visto que constitui espécie do gênero, cuja cobertura está prevista no Rol.Quanto a musicoterapia, equoterapia e hidroterapia em que pese sensível a situação do menor, não constam do rol vigente de cobertura mínima da ANS, ao contrário, tem sua exclusão expressa no Parecer Técnico n. 25 da ANS, o que afasta o dever de cobertura pela seguradora. Ademais, as coberturas devidas pelos planos de saúde são aquelas executadas por profissional da área da saúde, prestador de serviços de saúde, habilitado para sua realização, conforme legislação específica e regulamentação de seus respectivos Conselhos.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO(Apelação Cível, Nº 50118529020198210039, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 05-07-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DAS TERAPIAS INDICADAS PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. DESCABIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N 566/2022 DA ANS. HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora, após o diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista, postula a cobertura das terapias indicadas pelo médico, julgada parcialmente procedente na origem.O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ.No caso em comento, a parte autora comprovou quantum satis, a necessidade da realização do tratamento interdisciplinar do autor, com acompanhamento por tempo indeterminado de profissionais das áreas de Fonoaudiologia Terapia Ocupacional e Fisoiterapia.Segundo o art. 12, I, "a", e II, "a" e "b", da Lei n° 9.656/98, é vedada a limitação de prazo, de valor máximo e de quantidade consultas, atendimento e internações. Ademais, as terapias necessárias para o tratamento do autismo são contínuas e de longa duração, de modo que a limitação em número de sessões acabaria por prejudicar o próprio tratamento médico recomendado ao menor.Em que pese o argumento da demandada de que há previsão contratual de cobrança de coparticipação no percentual de 30% a 40%, o que não onera demasiadamente o segurado, não restou comprovado que ofertou profissionais capacitados dentro da rede credenciada, que justificasse o pagamento da coparticipação. Nesses casos, de acordo, com o que dispõe a RN 566/2022 da ANS, onde não houver prestador no município, credenciado ou não, que ofereça o serviço ou procedimento prescrito pelo médico assistente, a operadora do plano de saúde deverá arcar com o tratamento.Relativamente ao pleito de afastamento das terapias- Musicoterapia e Hidroterapia, em que pese sensível a situação do menor, o tratamento com hidroterapia e musicoterapia, de fato, não constam do rol vigente de cobertura mínima da ANS. Ademais, conforme consta no Parecer Técnico nº 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50051469020228210070, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2024)

No que tange ao postulado acompanhamento terapêutico, ainda que devida a cobertura de técnicas e métodos determinados pelo médico assistente, entendo, nos moldes do atual entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que eventuais sessões com os profissionais habilitados só possuirão cobertura caso realizadas em ambiente de consultório, ambulatorial ou hospitalar, não havendo, no entanto, como se obrigar o plano de saúde réu à postulada cobertura em ambiente escolar e/ou domiciliar, conforme postulado na exordial.

Nesta senda, também, colaciono as decisões da Superior Instância:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE COBERTURA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539 DA ANS, QUE REGULAMENTOU A COBERTURA OBRIGATÓRIA DE SESSÕES COM PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E FONOAUDIÓLOGOS, PARA O TRATAMENTO/MANEJO DOS BENEFICIÁRIOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, DETERMINANDO O OFERECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE ATENDIMENTO POR PRESTADOR APTO A EXECUTAR O MÉTODO OU TÉCNICA. EMBORA DEVIDA A COBERTURA DAS TÉCNICAS OU MÉTODOS DETERMINADOS PELOS MÉDICOS ASSISTENTES ESTAS DEVEM SER PRESTADAS DENTRO DAS SESSÕES COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DEVIDAMENTE HABILITADOS E EM AMBIENTE DE CONSULTÓRIO, AMBULATORIAL/HOSPITALAR. COBERTURA INDEVIDA DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO E ATENDIMENTOS EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 DA ANS. EQUOTERAPIA. EMBORA POSSÍVEL A COBERTURA DE TRATAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS, NOS TERMOS DO RECONHECIDO NO JULGAMENTO DO ERESP 1886929 E DO PREVISTO NA LEI 14.454/22, O CASO DOS AUTOS NÃO SE INCLUI EM QUALQUER DAS HIPÓTESE EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARECER TÉCNICO Nº 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 DA ANS. NOTA TÉCNICA 107833, EMITIDA PELO NATJUS QUE APONTA QUE A EQUOTERAPIA NÃO POSSUI EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE ÀS TERAPIAS CONVENCIONAIS COBERTAS, O QUE AFASTA O DEVER DE COBERTURA. TRATANDO-SE DE SEGURO SAÚDE, OS REEMBOLSOS DE ATENDIMENTOS PRESTADOS FORA DA REDE REFERENCIADA DEVEM OBSERVAR OS LIMITES ESTABELECIDOS NO CONTRATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRAZO DE CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/98. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51535052920218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 23-11-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA E BOBATH. COBERTURA DEVIDA EM AMBIENTE CLÍNICO E POR PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE. REEMBOLSO TRATAMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. LIBERALIDADE. REEMBOLSO NOS

LIMITES DA CONTRATAÇÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenizatória, através da qual a parte autora busca cobertura integral do tratamento multidisciplinar realizado com profissionais não credenciados, bem como o reembolso dos valores gastos com o tratamento já em andamento, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (CID 10: F84) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade — TDAH (CID 10: F90), julgada parcialmente procedente. Do tratamento multidisciplinar por método específico - Em consulta ao Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, relativo às coberturas - abordagens, técnicas e métodos - utilizados no tratamento do TEA, pode-se aferir que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a rigor, não descreve a técnica, abordagem ou método terapêutico a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas a agravos à saúde sob responsabilidade profissional, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, o que deve ficar a cargo do profissional assistente. De acordo com a Resolução Normativa n.º 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, com vigência a partir de 01º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicando pelo médico assistente para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA). Assim, é dever da operadora a cobertura do tratamento pelo método indicado pelo médico assistente, no caso: ABA E BOBATH. Do Assistente Terapêutico - O Acompanhamento Terapêutico caracteriza-se por atendimento, em regra, realizado no ambiente do paciente (casa, escola, outros espaços de convivência familiar e/ou social), ou seja, fora da clínica ou estabelecimento de saúde, visando à sua reinserção social e ao desenvolvimento de repertórios alternativos, entre outros. Em CASO DE necessidade de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, incumbe à instituição de ensino QUE O segurado frequenta disponibilizar um profissional de apoio, e não à administradora do plano de saúde, a teor do disposto na Lei n. 13.145/2015.A cobertura do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar não está contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, portanto, DEVE ficar limitada ao ambiente clínico, realizada por profissional da área da saúde (psicólogo/terapeuta ocupacional), o que afasta o dever de cobertura pela operadora, do tratamento em ambiente natural (escola/domiciliar). Da realização do tratamento na rede credenciada oferecida pela operadora - No caso dos autos, há efetiva indicação, pela operadora, da sua rede credenciada, inclusas no programa TEA: Clínicas SOS Saúde e HD 360 Moinhos, ambas na cidade de Porto Alegre, onde reside o menor. Não obstante tais indicações, a parte autora optou por realizar o tratamento com profissionais não credenciados, ao argumento de que o médico assistente orientou a manutenção dos profissionais que já atendiam o menor em função do vínculo estabelecido. Inobstante às alegações da parte autora, inclusive quanto a ausência de horários compatíveis com a disponibilidade do menor, fato é que não restou comprovado nos autos a impossibilidade de utilização da rede credenciada, de tal modo que, a opção pelos profissionais que atendem o menor, se deu por liberalidade da parte autora, não podendo ser imputada à operadora as despesas decorrentes dessa opção. Do reembolso - Pelos termos do contrato, não há qualquer imposição para que o segurado se utilize dos profissionais e estabelecimentos constantes da rede referenciada, ou seja, o segurado poderá realizar os procedimentos médicos que necessitar com médicos/hospitais não referenciados e posteriormente obter o reembolso pela operadora, entretanto, desde que obedecidos os limites da apólice por ele contratada.Assim, o reembolso deverá se dar dentro dos limites da contratação e não de maneira integral como postulado. Sentença reformada, no ponto. DUPLA APELAÇÃO. APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO, POR MAIORIA (Apelação Cível, Nº 51076124420238210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 02-08-2024)

Entendo, em estrita observância ao atual entendimento do STJ, que não há como se acolher os pleitos autorais inicialmente formulados, impondo-se, assim, a improcedência da totalidade dos pleitos autorais.

POSTO ISSO, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos inicialmente formulados na presente **AÇÃO ORDINÁRIA** ajuizada por **ERIKA ARAUJO TREMPER**, representada por sua genitora **CRISTINA FANTINEL ARAUJO**, devidamente qualificada nos autos, em face de **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A**, CONDENANDO a parte autora, por via de consequência, ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do procurador da parte requerida que ora arbitro em R$ 1.500,00, cuja exigência resta suspensa em face do deferimento da AJG à parte autora.

Em face da nova sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade (art. 1010, § 3º do NCPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Oportunamente, com o trânsito em julgado da presente decisão e no silêncio das partes, arquive-se o feito com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LAÉRCIO LUIZ SULCZINSKI, Juiz de Direito**, em 30/8/2024, às 16:52:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10062351415v18** e o código CRC **e640c66f**.